



L'EXAMEN CLINIQUE EN STOMATOLOGIE

Le Voyage du Diagnostic : De l'Observation à la Certitude

DÉFINIR NOTRE DÉMARCHE : QU'EST-CE QU'UN EXAMEN 'CLINIQUE' ?

Étymologie et Signification

- **Examen** : Du grec, 'sortir (ex) d'un groupe (agmen) les signes pathologiques'.
- **Stomatologie** : Du grec 'stoma' (bouche) et 'logos' (discours). L'étude de la bouche et de ses annexes.
- **Clinique** : Il est « clinique » lorsqu'il se pratique au fauteuil, c'est-à-dire sans l'aide de moyens de laboratoire.

Le Principe Fondamental

L'examen clinique demeure l'étape initiale essentielle dans l'approche diagnostique de toute pathologie médicale. C'est le point de départ de toute réflexion.





ÉTAPE 1 : L'INTERROGATOIRE

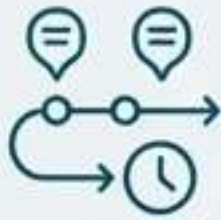
La première source d'information, c'est le patient.
Apprendre à écouter est la première compétence du clinicien.

LA STRUCTURE DE L'INTERROGATOIRE : RECUEILLIR LES INDICES



1. État Civil et Motif de la Consultation :

- Enregistrer les données de base (nom, âge, profession).
- Identifier les symptômes et troubles fonctionnels ressentis par le patient. *Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ?*



2. Histoire de la Maladie :

- La plus grande importance est donnée à la chronologie des faits.
- Rechercher le facteur déclenchant (Quand ? Comment ?).
- Analyser le mode évolutif et les traitements déjà entrepris.
- Noter les répercussions sur l'état général (fièvre, amaigrissement, asthénie).



3. Antécédents Personnels et Habitudes de Vie :

- Médicaux et chirurgicaux.
- Traitements en cours (anticoagulants, etc.), allergies.
- Intoxication (alcool, tabac).



4. La Confiance :

- Il est important de laisser l'intéressé s'exprimer selon sa propre terminologie en le guidant sans l'influencer. L'interrogatoire conditionne les rapports de confiance ultérieurs.

ÉTAPE 2 : L'EXAMEN PHYSIQUE

Après l'écoute, vient l'observation. La démarche se fait de l'extérieur vers l'intérieur.



Inspection : *Inspectare* - 'Regarder dans'. Ce que l'on voit.

1. Examen Cervicofacial (Extra-oral)



Palpation : *Palpare* - 'Toucher'. Ce que l'on sent.

2. Examen Endobuccal (Intra-oral)

L'EXAMEN CERVICOFACIAL : LES SIGNES EXTÉRIEURS

1. Inspection :

- **Statique** : Rechercher une **asymétrie faciale**. Est-elle d'origine inflammatoire, infectieuse, ou tumorale ? Observer la couleur de la peau (ictère, pâleur).
- **Dynamique** : Évaluer la motricité des muscles de la face et la mimique.

2. Palpation :

- Rechercher des tuméfactions, des points douloureux, et évaluer la chaleur locale.
- Tester la sensibilité des différents territoires nerveux.

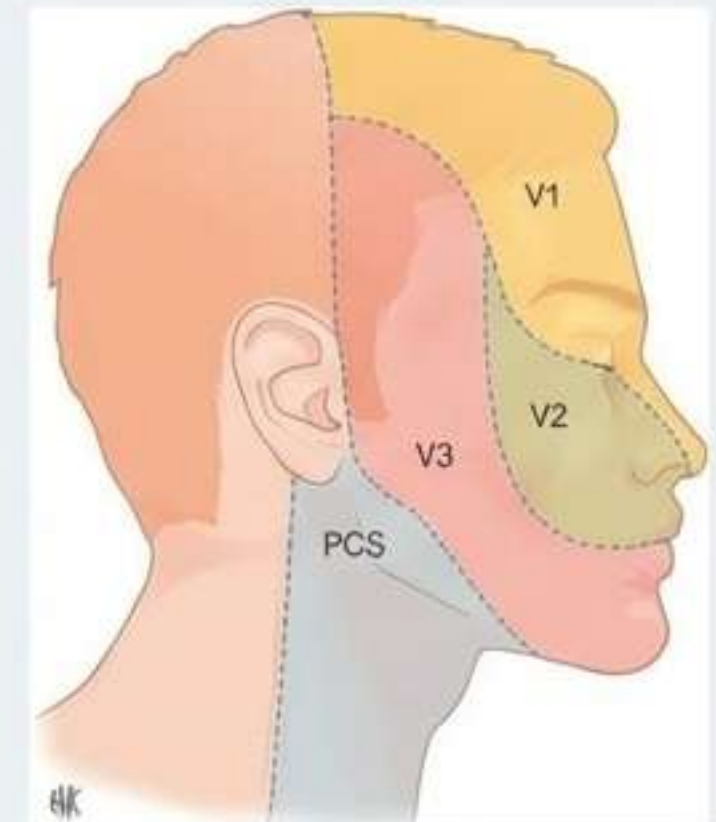
Rappel Anatomique Essentiel : Territoires Sensitifs

V1 : Nerf ophtalmique

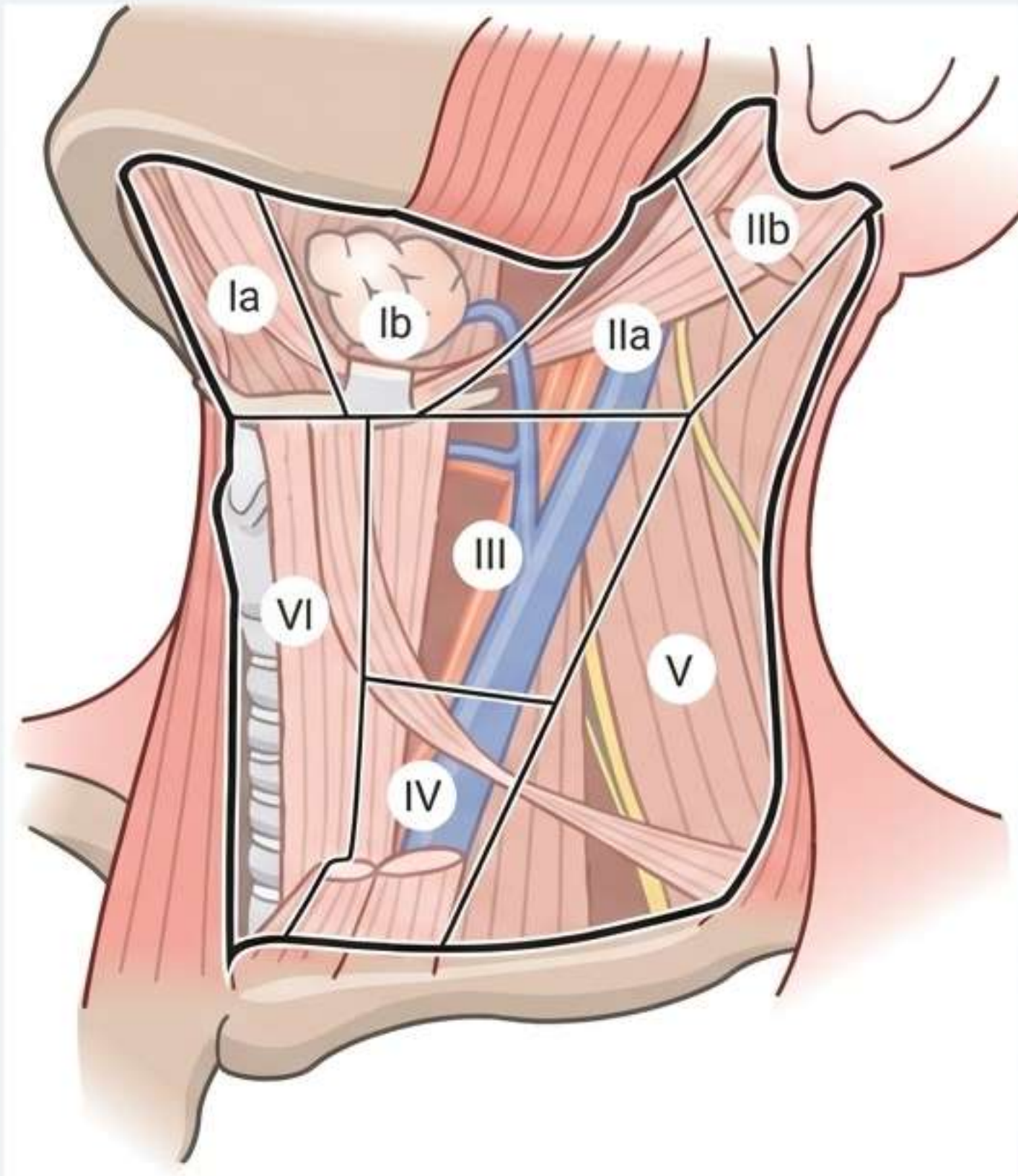
V2 : Nerf maxillaire

V3 : Nerf mandibulaire

PCS : Plexus cervical superficiel



FOCUS SUR LA PALPATION : LES AIRES GANGLIONNAIRES CERVICALES



Objectif: Rechercher des adénopathies, qui sont des signes clés d'infection, d'inflammation ou de malignité.

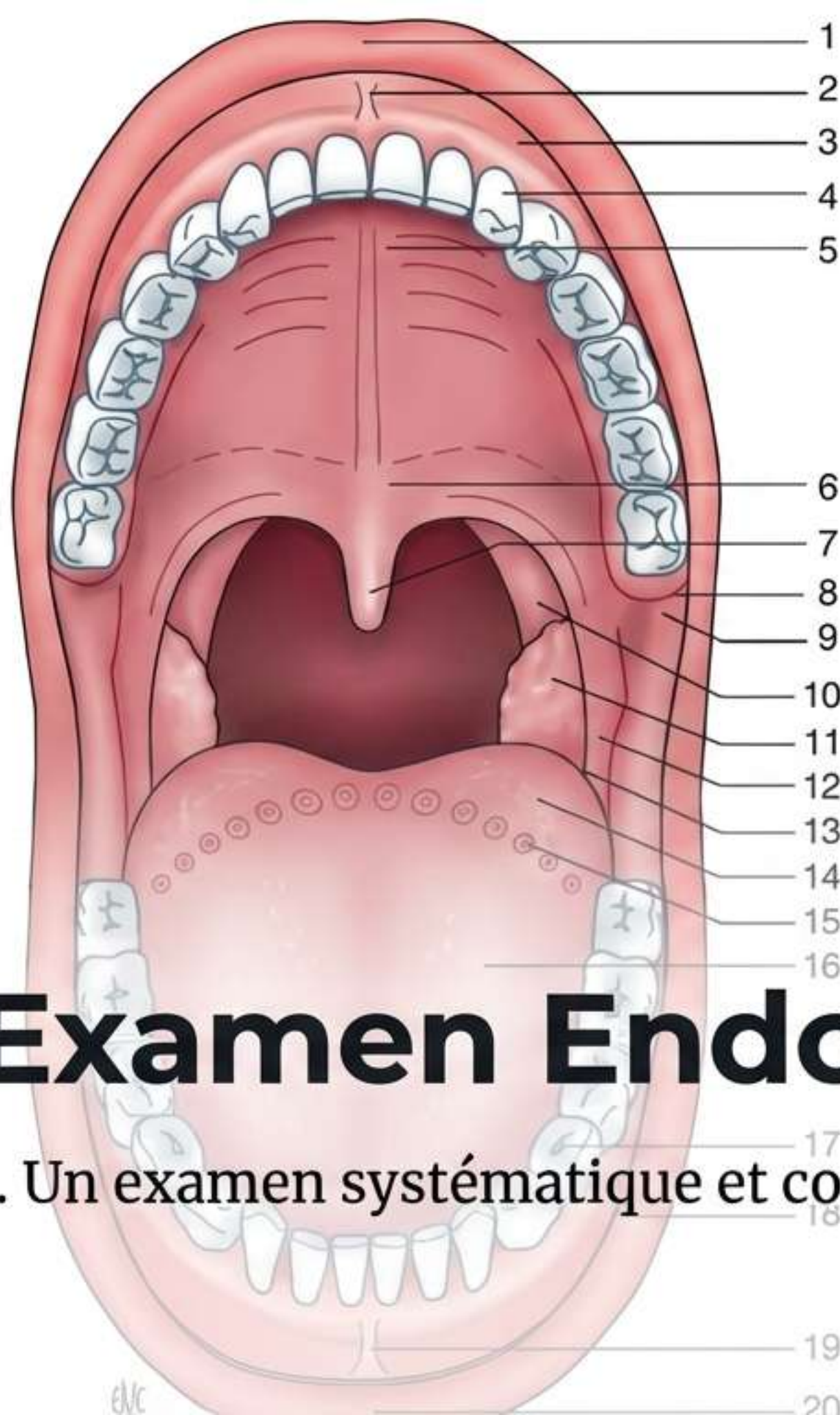
Caractéristiques à Évaluer pour chaque ganglion palpé :

- **Volume / Taille :** Mesurer en centimètres (ex: 1 cm, > 2 cm).
- **Consistance :** Molle (inflammatoire), ferme, dure/ligneuse (tumorale).
- **Mobilité :** Mobile par rapport aux plans profonds et superficiels, ou fixe.
- **Sensibilité :** Douloureux (généralement inflammatoire) ou indolore.
- **Nombre :** Unique ou multiple.



Étape 3 : L'Examen Endobuccal

Le cœur de notre spécialité. Un examen systématique et complet de toutes les structures.



LES OUTILS ET LE PREMIER REGARD : L'ORIFICE BUCCAL

1. Le Plateau d'Examen Essentiel (Q1)

Le plateau utilisé pour l'examen intra-oral doit comporter les éléments suivants (Q1) :

- Sonde exploratrice (Q1)
- Miroir d'examen (Q1)
- Précelles (Q1)

(Note: Brunissoir et Fraises ne sont pas des instruments d'examen de base)



2. L'Examen de l'Orifice Buccal

- **Examen Statique** : sont analysées la forme et les dimensions de l'orifice buccal, l'état de la muqueuse labiale (sécheresse, compétence labiale).
- **Examen Dynamique** : note principalement la tonicité de l'orbiculaire.

EXAMEN DES STRUCTURES CLÉS : FREINS ET LANGUE

1. L'Examen des Freins (Q2)

Un examen attentif des freins peut révéler (Q2) :

- Une ankyloglossie pour les freins linguaux courts. (Q2) (Important)
- Un diastème inter-incisif pour le frein labial supérieur. (Q2) (Important)
- Une récession gingivale pour le frein labial inférieur. (Q2) (Important)
- Une hypertrophie. (Q2)
- (Toutes les réponses sont justes)



Fig. 1 : Frein labial supérieur associé à un diastème.

2. L'Examen de la Langue

- **Inspection** : Aspect de la surface (papilles), couleur, recherche de lésions sur toutes les faces (dos, ventre, bords). Utiliser une compresse pour la mobiliser.
- **Palpation** : Recherche d'induration.
- **Exemples pathologiques** : Langue géographique, langue chevelue (leucoplasie vilieuse), candidose.



Fig. 2 : Examen de la langue avec une compresse.



Fig. 3 : Langue géographique.



Fig. 4 : Leucoplasie vilieuse orale.

EXAMEN DES GLANDES SALIVAIRES : UN POINT CRUCIAL

1. La Démarche Clinique (Q3)

Lors de l'examen des glandes salivaires, on recherche (Q3) :

- Une tuméfaction rythmée par les repas (pathologie lithiasique). (Q3)
- L'aspect de la salive à l'ostium (épaisse, purulente) après expression manuelle. (Q3)
- Une sécheresse buccale. (Q3)
- La technique d'examen principale est le **Palper bimanuel du plancher buccal**.

2. Signes de Malignité à ne Jamais Manquer (Q3)

- Une paralysie faciale (signe de malignité pour la parotide). (Q3) **(Important)**
- **Une hypoesthésie linguale** (signe de malignité pour la glande sous-mandibulaire).
- Adénopathies cervicales associées.



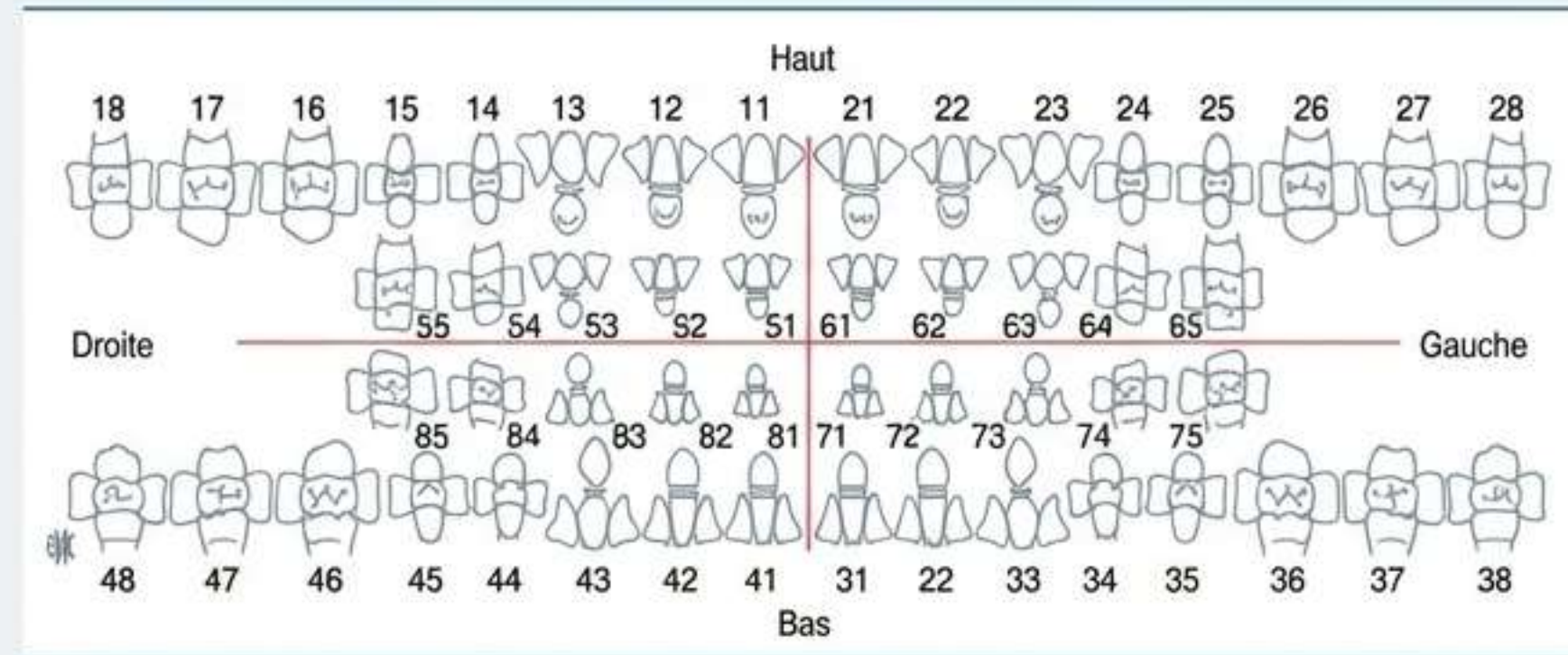
Fig. 1 : Palper bimanuel du plancher buccal.

(Toutes les réponses sont justes pour Q3)

EXAMEN DE LA DENTURE ET DU PARODONTE

1. Examen Dent par Dent :

- **Inspection** : Recherche de caries, d'obturations défectueuses, de malpositions, de fractures.
- **Couleur (Dyschromie)** : Peut indiquer une nécrose pulpaire.
- **Mobilité** : Évaluer la mobilité physiologique ($< 0.2\text{mm}$) vs pathologique.
- **Percussion** : Axiale et transversale pour rechercher une sensibilité.

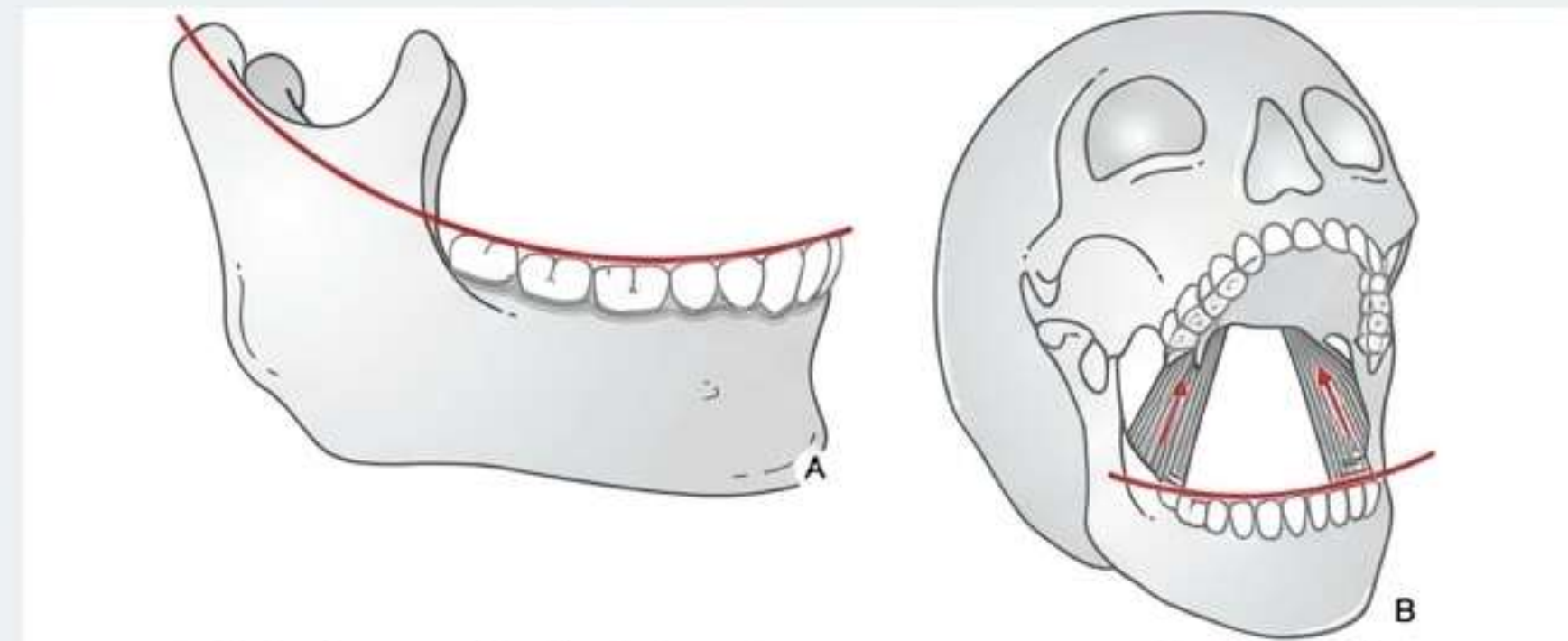


2. Examen du Parodonte :

- **Gencive** : Couleur, inflammation, saignement au sondage, récessions.
- **Sondage** : Mesure des poches parodontales.

3. Examen de l'Occlusion :

- **Intercuspitation Maximale (ICM)** : Évaluer le nombre et la qualité des contacts.
- **Courbes de Compensation** : Observer la **Courbe de Spee** (sagittale) et la **Courbe de Wilson** (frontale).
- **Mouvements** : Analyser la propulsion et la diduction (latéralité).



A. Courbes de compensation (d'après Dawson).

A. La courbe de Spee commence à la pointe canine et suit les pointes cuspidiennes des prémolaires et molaires.

B. La courbe de Wilson est la courbe transversale passant par les pointes vestibulaires et linguales des dents mandibulaires.

C. La courbe de Wilson.

L. La courbe de Spee et la courbe des bords incisifs forment la courbe d'occlusion (plan d'occlusion).



Interrogatoire



Examen Extra-oral



Examen Intra-oral

Étape 4 : La Synthèse Diagnostique

Confronter les données de l'interrogatoire et de l'examen clinique pour aboutir à une certitude.

Diagnostic

LE PROCESSUS DU DIAGNOSTIC : DE L'HYPOTHÈSE À LA CERTITUDE

1. Le Diagnostic Différentiel

- Définition : L'aboutissement à un diagnostic de certitude se fait progressivement en éliminant au fur et à mesure les affections dont les signes... ne correspondent pas à ceux retrouvés chez le malade.
- C'est la liste des diagnostics possibles.

2. Le Diagnostic Positif (Q4)

- Définition : C'est le diagnostic de certitude. (Q4-B)
Il résulte de la confrontation des données de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des examens complémentaires.
- Ce n'est pas un choix au hasard, mais la conclusion logique de l'analyse.

Citation du professeur :

Le diagnostic, c'est que j'ai posé un diagnostic. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un si vous n'avez pas trouvé un diagnostic.

LA FINALITÉ DE NOTRE DÉMARCHE



“Aucune maladie ne peut être correctement traitée tant qu’un diagnostic précis n’a pas été convenablement posé.”

L'examen clinique n'est pas une simple liste de tâches, c'est la pierre angulaire de la thérapie.